

2

Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté

Septembre 1997

Monsieur B m'est adressé en consultation par Marie-Christine Soula, médecin inspecteur du travail, qui vient de créer la deuxième consultation « Souffrance et Travail » à Garches. Dans sa lettre, elle décrit un patient enfoncé dans un tableau dépressif lourd, une prostration et un mutisme importants. En dépit d'un entretien prolongé, elle n'a rien pu en sortir.

Il est assis devant moi, lourd, trapu, prostré toujours. Attention, je dois ménager ses défenses ! Je démarre toujours l'entretien clinique sur les éléments de vie personnelle avant d'insister sur la trajectoire professionnelle. Ce retour à des éléments d'histoire de métier lève souvent le mutisme. C'est le cas avec Monsieur B. D'une voix plus audible, il me dit être issu d'une fratrie de sept enfants, titulaire d'un CAP de tourneur-ajusteur. Il a fait ensuite des formations successives sur différents postes de travail

en mécanique auto, maçonnerie, charpente, marbrerie. Nous voilà sur le terrain de ses compétences concrètes.

« Marbrier, c'est un beau métier !

– Oui, il faut de la minutie, un geste sûr. La pierre ne pardonne pas l'erreur.

– Vous pouvez me parler de votre dernier poste ? »

C'est sur la base de ses connaissances en marbrerie qu'on l'a embauché comme agent technique dans une mairie.

« On m'avait laissé entendre que le chef d'équipe allait partir à la retraite et qu'avec ma formation j'allais prendre sa suite.

– Une grosse équipe ?

– Au cimetière intercommunal, dans une petite équipe de six personnes. Le chef d'équipe est parti à la retraite quelques semaines plus tard.

– Et on vous a donné son poste, comme prévu ?

– Non. J'avais des problèmes de jalousie avec mes collègues. »

De nouveau, Monsieur B se referme. Mutisme. Peur dans le regard. Je lui laisse du temps. Et soudain, il enchaîne : « C'était dur de s'intégrer. Il y avait des dysfonctionnements dans le déroulement des travaux. »

Drôle de mot dans sa bouche... Un marbrier qui parle de dysfonctionnements dans le travail, c'est peu courant. C'est plutôt mon vocabulaire à moi. Que veut-il dire ?

La manière dont il a prononcé ces mots, les yeux emplis de terreur, me rappelle aussitôt d'autres patients, plongés dans l'effroi eux aussi.

L'ouvrier dont la manche du bleu de travail s'était prise dans la machine qui avait emporté sa main, puis son bras, jusqu'à l'épaule. La panique générale des collègues qui tentaient de stopper l'engin, jusqu'à ce que le chef d'atelier

trouve le fusible central de toutes les machines. Il racontait sans arrêt la séquence comme pour en désamorcer la charge traumatique. Écouler l'effroi, mot après mot.

L'enseignante qui ne pouvait plus mettre les pieds dans le vestiaire où des dizaines de photocopies d'elle avaient été scotchées au plafond. Elle, entre deux hommes, en train de faire ce que l'imaginaire pornographique de son responsable dégorgeait. Son effroi et le mien devant les photocopies étalées sur mon bureau. Mon effroi intérieur quand elle raconte le silence gêné de ses collègues et leur consentement passif.

La femme de chambre d'une chaîne d'hôtels à qui l'on avait demandé de nettoyer celle où un mari avait réglé leur compte à son épouse et à son amant. L'effroi devant le sang sur les murs, le matelas imbibé qu'il faut traîner dans le couloir, la violence du meurtre dont elle lit les détails dans les journaux locaux et dont elle doit effacer les traces.

Pour pouvoir verbaliser des événements indicibles, le patient doit absolument percevoir que le clinicien connaît la réalité du monde du travail. Je le dis à Monsieur B : « Je connais le monde du travail. Et je sais qu'il s'y passe quelquefois des choses très dures à supporter. Je peux entendre ce que vous n'arrivez pas à dire. »

Monsieur B, le regard fixe, évoque alors les événements qui semblent encore avoir pour lui valeur de réalité imminente :

« Je ne faisais pas que de la gravure de pierre tombale. Je devais faire les mêmes tâches que les autres. En plus de nettoyer les allées, les fleurs, en plus d'entretenir les tombes, nous étions chargés d'exhumer des morts pour des transferts. Des fois, les familles changent de caveau. Elles quittent une région, elles emportent leurs morts. Il faut sortir le cercueil de terre, l'ouvrir, vérifier l'état des corps.

C'était dur, nous n'étions pas préparés à affronter ça. En tout cas, pas moi. Moi, on m'avait embauché comme marbrier. Pas pour exhumer des corps !

Deux exhumations m'ont marqué. On a sorti un cercueil qu'on a ouvert pour vérifier l'état du corps. C'était une femme qui était comme momifiée, avec les seins plats, vidés, les yeux exorbités. Après ça, je n'ai plus jamais pu toucher une femme.

Il y a eu un homme aussi, dont la tête a bougé quand j'ai ouvert le cercueil qui était plein d'eau. On a lâché le cercueil et on est tous partis en hurlant de peur ! C'étaient des visions terribles qui me hantent encore maintenant. »

Disant cela, Monsieur B est encore dans le cimetière, devant les cercueils ouverts. Le mort saisit le vif. Terrible suspens de la pensée post-traumatique : les images sont là avec leur trop-plein de réel et suspendent le fil normal de la pensée consciente ou inconsciente. Elles reviennent quoi qu'on fasse, à leur gré, quand elles le décident. Au volant de sa voiture, au travail, chez soi, tout d'un coup, par des mécanismes d'analogie – couleur, odeur, son, texture –, elles apparaissent, s'imposent, défilent comme un film intérieur et vous replongent dans l'effroi. Elles répètent à l'identique la scène originelle. Elles épuisent la psyché et le corps. On s'endort, elles reviennent au travers des cauchemars. On s'empêche de dormir, elles défilent en surimpression de la réalité comme un film intérieur.

« Quelquefois, mes collègues faisaient un seul corps avec deux morceaux trouvés ailleurs. Ou le cercueil transféré repartait avec de la terre dedans, c'est tout, sans être ouvert, pour faire croire au poids d'un corps... »

Le patient a, d'évidence, développé des signes de névrose post-traumatique, non diagnostiquée, non traitée. Tout y est : l'hébétude, le rétrécissement du champ de conscience, le

retrait social, l'hypersensibilité sensorielle, l'anxiété panique, la reviviscence des scènes traumatiques vécues, les cauchemars de répétition, l'évitement phobique du lieu de travail.

Forcément, je m'interroge sur le reste de l'équipe. Et les autres, comment se débrouillaient-ils avec les particularités de ce travail ?

« Mes collègues buvaient beaucoup. Ils s'alcoolisaient avant d'arriver dans le cimetière la nuit, pour sortir le cercueil. »

L'histoire prend tournure. Monsieur B débarque dans une équipe soudée depuis longtemps, et qui, pour tenir face à la souffrance engendrée par ce type d'activités, a dû développer des stratégies collectives de défenses particulières : la consommation d'alcool, tout d'abord, qui vise à tamponner la souffrance et à souder le collectif de travail autour d'une pratique virile commune. L'anesthésie émotionnelle qui en découle permet sûrement de mieux faire le sale boulot. En effet, ce n'est pas l'alcoolisation qui est amenée au travail, c'est le travail qui amène à l'alcoolisation.

Mais l'alcoolisation entraîne aussi la levée des inhibitions, des mécanismes de censure morale, et donc l'apparition de comportements limites. Monsieur B n'a pas encore tout dit.

« En dehors de l'alcool, comment votre équipe se débrouillait-elle pour "faire le travail" ?

— Ils piquaient les bijoux sur les morts, des bagues, des colliers... Ils disaient qu'il fallait se payer pour un travail pareil. »

Pauvre équipe, livrée à elle-même, dans l'obligation de mettre en place des solutions personnelles, faute de solutions délibérées collectivement avec la hiérarchie. La levée des inhibitions entraîne toujours des conduites de dérapage éthique.

Je pense à la bague de fiançailles et à l'alliance que nous avons laissées au doigt de notre mère, ma sœur et moi. Il est dur d'entendre que des pillages de biens précieux sur des corps exhumés se faisaient régulièrement dans ce cimetière. Et, bien sûr, seule la coopération de tous assurait la banalisation de ces actes effectués collectivement. La conscience morale se dissout dans l'alcool et dans l'entraînement collectif.

Dans de nombreux métiers, l'exposition aux situations complexes, avec la peur qui en découle, est constante. Dans le BTP, quand il faut monter sur un échafaudage. Chez les pompiers, quand il faut entrer dans le feu. Chez les policiers...

À chaque fois, il s'agit bien de conjurer la peur. De dénier le danger de la situation de travail pour aller travailler malgré tout. Sans quoi le sentiment de peur deviendrait incompatible avec la poursuite du travail. Alors les travailleurs érigent en défense une « culture de la virilité » qui vise à tourner en dérision le danger. La désobéissance et l'indiscipline sont des comportements habituels connotés positivement comme signes extérieurs de courage. Ils pratiquent bravades et défis, affichent un goût certain pour les manifestations de force musculaire, d'agilité, voire de prouesses physiques. Les « concours » constituent la vie ordinaire des métiers à risque. Si on ne s'y plie pas, on est une « pédale », « une femmelette ». On n'est pas un homme. Se plaindre, être angoissé, hésitant, inquiet sont considérées comme des attitudes efféminées. Alors, on ne parle pas de sa peur. Le maintien de ce déni collectif soude le groupe.

C'est parce que tous partagent la stratégie collective de défense que les collègues se reconnaissent entre eux comme membres du même collectif et qu'ils « tiennent » au travail. Ces stratégies défensives ont les inconvénients qu'on

imagine, mais elles ont une valeur fonctionnelle fondamentale. Quand on écoute Monsieur B, on comprend qu'elles servent à dénier les cadavres.

Malheur à celui qui ne souscrit pas à la stratégie défensive : par son seul comportement timoré, il devient une menace pour le groupe.

Monsieur B va se démarquer immédiatement par son refus de boire de l'alcool pendant le travail et de piller les corps. Et ce refus d'adhérer aux pratiques collectives va sceller son destin de bouc émissaire.

« Très vite on m'appelle "le gros". C'est vrai, je suis gros. C'était pour m'humilier. On m'insultait tous les jours. Comme je ne faisais pas comme eux, je dérangeais. Peut-être que je leur faisais peur. Ils me houspillaient tellement, tout le temps, que j'ai fini par me replier. J'ai décidé de travailler tout seul dans mon coin. »

Classiquement, son repli a dû être interprété comme une mise à distance et a déclenché en retour sa mise au ban. On ne lui parle plus. Un jour, un de ses collègues menace de le « planter » avec un couteau.

Monsieur B entre alors dans une logique de contestation de sa situation d'exclusion. Il envoie de nombreuses lettres au maire, est reçu par le directeur des services techniques et par son chef de service. Il raconte ce qui se passe la nuit dans le cimetière. Comme si le chef de service ne le savait pas ! En effet, dans chaque récit de situation de maltraitance au travail, vient toujours le moment du constat de la défaillance de l'analyse du travail réel, de la défaillance du management.

À ce stade du récit, on se dit que tout pourrait rentrer dans l'ordre. On embaucherait enfin l'officier assermenté qui doit normalement assister aux ouvertures de tombes. On réunirait cette équipe pour punir les débordements, certes, mais surtout pour débattre collectivement des

moyens de faire face à la rencontre avec les morts : accompagnement psychologique, règles de métier précises pour conjurer l'angoisse, etc.

Rien de tout cela n'arrive. Celui qui dit la vérité doit être éliminé. J'écoute le récit de Monsieur B sur la persécution qu'il subit. Mais, au-delà de ce récit, forcément subjectif, pour objectiver la situation de discrimination, j'ai sous les yeux ses fiches d'évaluation : une baisse de note très brutale, de 18,5 à 10, cette année-là. Incroyable, une telle baisse de note dans la fonction publique ! Au pire, on vous enlève un point mais pas 8,5 !

Bien sûr, Monsieur B conteste et obtient la révision de cette note, ce qui n'a pas dû améliorer sa situation. Je compte aussi plus de six demandes de mutation en province, toutes refusées, ce qui le place dans une impasse majeure : on ne veut pas qu'il reste, on ne veut pas qu'il parte.

Nous nous trouvons ici dans un cas de harcèlement transversal ou de « mobbing » au sens strict de la définition de Leymann : « Par mobbing, nous entendons une situation communicative qui menace d'infliger à l'individu de graves dommages, psychiques et physiques. Le mobbing est un processus de destruction : il est constitué d'agissements hostiles qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, mais dont la répétition a des effets pernicieux... Une des situations de mobbing concerne les agressions entre collègues. Le groupe contraint l'individu réticent à se conformer aux normes fixées par la majorité¹. » Il faut ajouter à ce mobbing collectif, le traitement bureaucratique inadéquat qui a été fait de cette situation.

1. Heinz Leymann, *Mobbing*, Le Seuil, 1996.

Il faut mesurer à quel point la mise au ban du groupe, la désaffiliation du collectif de travail représentent une authentique expérience d'aliénation sociale.

Les harcelés ne sont pas des salariés plus fragiles que les autres. Bien au contraire, ils se situent souvent du côté de l'authentique, du travail bien fait, dans les règles. Ils deviennent rapidement un corps étranger dans un collectif plus docile, plus laxiste, plus « je-m'en-foutiste ». L'attaque exercée contre eux porte sur une posture : le juste et l'injuste, le vrai et le faux, le bien et le mal.

Monsieur B me dit qu'il tient grâce à de petits arrêts maladie transitoires et au soutien de son médecin généraliste. Mais il décrit aussi toutes les procédures judiciaires dans lesquelles il est engagé depuis deux ans, auprès des tribunaux administratif et pénal, sur la base de la notion de harcèlement moral, pourtant non encore légiférée à l'époque.

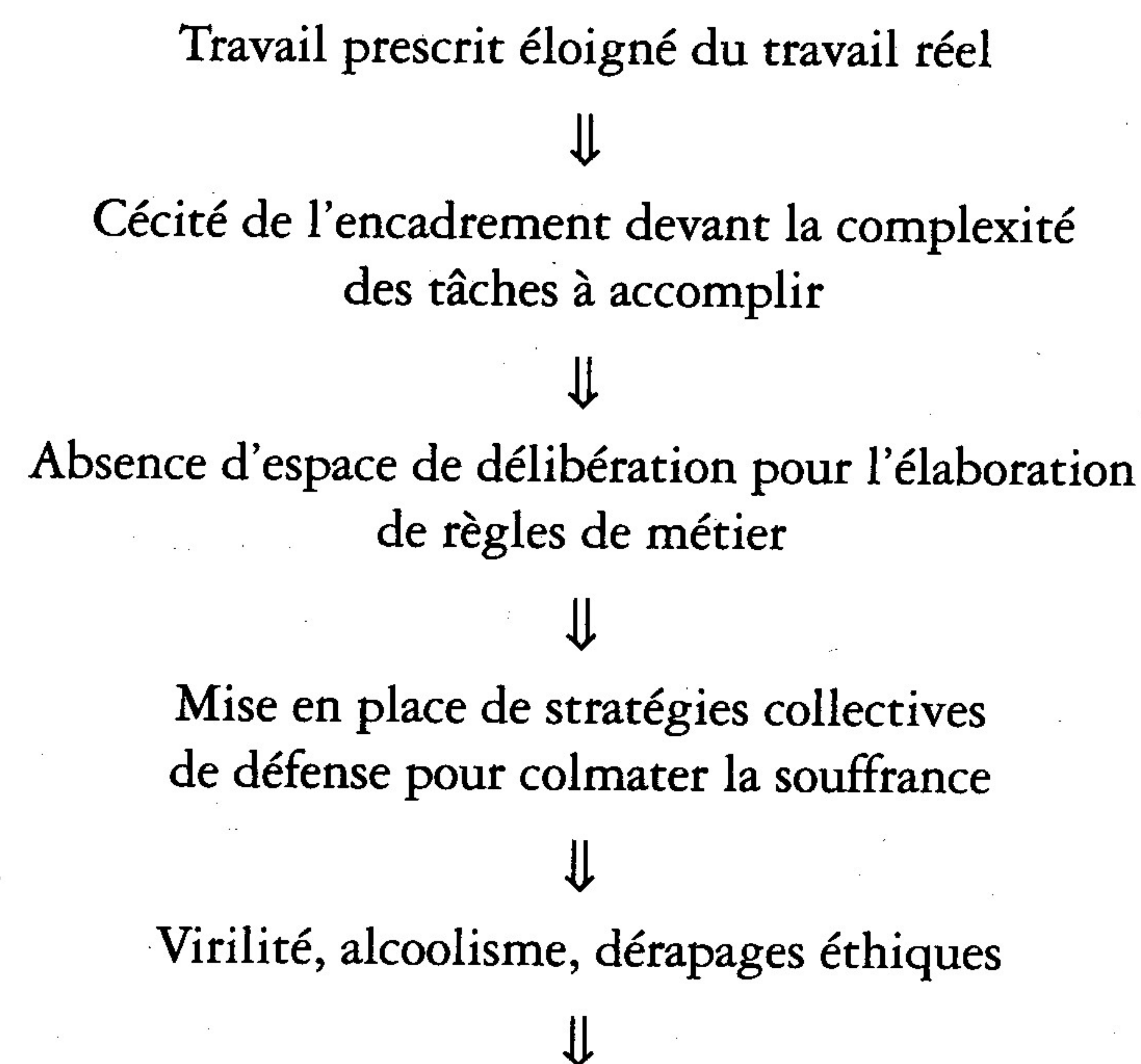
Son état nécessite en tout cas l'orientation vers une prise en charge psychiatrique afin de lui permettre d'élaborer l'angoisse de mort liée à la rencontre avec tous ces cadavres traumatisants. Il faut tenter de résorber la souffrance subie et de rétablir la justesse de son socle de valeurs. On ne peut pas traiter un patient victime de traumatisme intentionnel comme les autres. Le risque « de confondre la position de dominé avec une déviation psychonévrotique, masochiste² » est constant, tant chez le patient que chez le thérapeute qui laisse l'organisation du travail à la porte de son cabinet. Non, les harcelés n'apportent pas leur consentement pulsionnel à la maltraitance qu'ils subissent. Ne pas reconnaître la maltraitance de la part de

2. Pascale Molinier, « Autonomie morale subjective, théorie psychanalytique des instances morales et psychodynamique du travail », *Travailler*, n° 1, 1998, p. 55-69.

ses « collègues » et de son institution et le ramener à la part névrotique de son histoire infantile revient à maltraiter le patient par les théories et notre pratique clinique.

Le temps est venu d'aborder avec Monsieur B les raisons de sa mise au ban, de la désaffiliation de la communauté d'appartenance. En effet, les situations de travail où le rapport au réel est remis en cause sans que le travailleur puisse le partager avec ses collègues sont dangereuses pour la santé mentale. L'identité est inséparable des actes techniques effectués par le sujet. Au travail, la reconnaissance obtenue dans le registre du faire est intégrée dans le registre de l'être. Se retrouver seul à porter une vérité sur l'exécution correcte du travail place le sujet en situation d'aliénation sociale. Mis au ban, méprisé, critiqué, il peut en venir à douter de la réalité de sa perception et basculer dans l'aliénation mentale.

Je lui propose un enchaînement de causes :



Refus du nouvel arrivant d'adhérer
aux stratégies collectives de défense



Mise au ban



Surdit  de la hi rarchie qui couvre



Risque de mise au jour des d rives



Pers cution

Cette reconstruction chronologique est salvatrice. Elle permet de d coller l'histoire singuli re et l'histoire au travail. Monsieur B n'a pas  t  harcel  pour ce qu'il est mais pour ses valeurs de m tier, sa mani re de travailler. Aucune th orisation ne pourra me convaincre qu'aller d noncer   son sup rieur hi rarchique le pillage de caveaux rel ve d'une symptomatologie psychique. L'honn tet  serait donc une pathologie ? Une na ivet  de mauvais aloi ? Nous sommes l  dans la lourdeur, la gravit  et le cynisme des rapports sociaux, dans les rapports de domination et de soumission qui s'exercent dans le monde du travail comme ailleurs.

Outre la d compensation psychique, Monsieur B souffre d'une hypertension s v re et non trait e. Le retour au travail serait d l t re. Un cong  longue maladie est obtenu par Marie-Christine Soula, afin de traiter sa grave d pression et de stabiliser son hypertension art rielle. Monsieur B arrivera ainsi   l' ge de sa retraite sans basculer dans la pr carit .

Il n'en demeure pas moins que les conditions de travail dans ce cimet re communal, source de souffrance, de

consommation d'alcool et de conduites assimilables   des d rives  thiques, m riteraient d' tre analys es afin de d boucher sur l' dification de v ritables r gles de m tier. Mais il semble ici que la hi rarchie, l'absence d'un m decin de pr vention sur ce secteur ne permettent pas la prise en charge de ce collectif en souffrance.

De nouveau, la souffrance au travail nous fait aboutir aux impasses et aux d faillances de l'encadrement qui g n rent une perte des r gles  thiques,   la difficile description de l'activit  du travail sans les outils th oriques ad quats. Dans d'autres cimet res intercommunaux, les r gles sont correctement appliqu es, un officier asserment  est l  pour cadrer et les chefs d' quipe sont attentifs   l'impact de la proximit  de la mort sur le psychisme de leurs agents.